

ІННОВАЦІЯ

ОНКОЛОГІЧНА КЛІНІКА

ТОВ "Медична клініка "Інновація"
тел. (044) 331-21-00, (067)
503-59-22Ліцензія АЕ 459319 від 27.08.2014
видає МОЗ України

www.innovacia.com.ua

ІННОВАЦІЯ

ОНКОЛОГІЧНА КЛІНІКА

Код форми за ЗЮД

Код закладу за ЗЛПО 36076865

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 028/0

Затверджено наказом МОЗ України

14.02.2012 р. № 110

ЕпікризПациєнт Жерліцина Анастасія Станіславівна, 46 років
Телефон № (м): 0685975246

ЕМК № 7140773

Документ № IX-230208/5611.E1/1

Картка № Стационарна карта № IX-230208/5611 від 09.02.2023

Відділення Поліклінічне відділення

СК

Поліс №

Координатор

від 15.02.2023 8:41:00

Лікар Лацинківа Оксана Миколаївна

Пациєнтка Жерліцина А. С., 1976р.н., знаходилася на лікуванні 09-15.02.2023р. в умовах стаціонару клініки "Інновація".

Діагноз: Лейоміосаркома матки T2NxM1 (печінка, брюшина).

Стан після 4-х циклів хіміотерапії по протоколу Гемцитабін+Доцетаксел+Авастин з прогресією в печінці (МРТ ОЧП, ОМТ 14.10.2022, КТ 01.12.2022).

Виявлено мутації Kit, MET (повногеномне секвенування ONCOMINE, 12.2022).

Лікування Пазопанібом 05-12.01.2023р. з розвитком синдрому задньої зворотньої енцефалопатії та позитивною динамікою по даним КТ від 09.02.2023р. Заключення: КТ-ознаки вторинного ураження паренхіми печінки, міжпечельний імплант лівого мезогастрія, об'ємне утворення в проекції правого яєчника (імплант в Дугласовому просторі?), мінімальні ознаки біліарної гіпертензії. Від 04.01.2023р динаміка позитивна - регрес вогнищ в печінці на 12%, зменшення в розмірах міжпечельного імпланту на 15%.

Супутній діагноз: Залізодефіцитна анемія. Цукровий діабет 2 тип. Гіповітаміноз Д.

Закритий відламковий перелом дистального метаепіфізу лівої променевої кістки зі зміщенням відламків (11.02.2023р.)

Актуальна госпіталізація: 1-й цикл хіміотерапії за протоколом Трабектідин (редукція дози на 20%).

13.02.2023р. -імплантована система для внутрішньовенних інфузій Port-A-Cat.

Скарги на порушення концентрації в другій половині дня, частий стілець (до 5 раз на день).

Об'єктивно: загальний стан задовільний. Шкірні покриви і видимі слизові оболонки звичайного забарвлення, чисті. Дихання везикулярне, вислуховується на всьому протязі, хрипів немає. Діяльність серця ритмічна, тони звучні. Живіт м'який, безболісний при пальпації, печінка збільшена до рівня пупка, активна перистальтика. Діурез - достатній, стілець- частий, до 5 раз на день, сформований.

У рамках 1-го циклу хіміотерапії пацієнтка отримала Йонделіс 2 мг.

Супровідна терапія включала дексаметазон, еменд, зофран, контролок, сольові розчини еліквіс, глюкофаж, сорбіфер, тивортин, гептрал, глутаргін, сольові розчини, кораксан, дуфалак, пантопрозол, Кальцій+Д3, лінекс, Зарсію, цикло 3-форте, аертал.

11.02.2023р. в 18.30 в результаті падіння пацієнтка отримала перелом нижнього кінця променевої кістки зі зміщенням.

13.02.2023р. КТ голови. Заключення: Ділянка зниженої щільності субкортикально в лівій потиличній долі може відповідати зоні ішемії, як ознаки залишкових явищ PRES-енцефалопатії. Ретроспективно за даними МРТ від 13.01.2023 р. - МР-ознаки PRES-енцефалопатії.

13.02.2023р. консультована травматологом. Виконана закрита репозиція. Рекомендації надані (клініка Адоніс. Заключення на руках).

Лікування перенісла задовільно.

Результати аналізів додані.

2-й цикл хіміотерапії заплановано на 02.03.2023р.

Рекомендовано:

1. При нудоті - Зофетрон по 8 мг (1 таб) всередину, максимальна добова доза - 32 мг (4 таблетки на добу), також можливий прийом Церукалу по 10-20 мг (1-2 таблетки), до 6 таблеток на день, у 2-3 прийоми.
2. При явищах мукозиту (почервоніння, набряклість, виразка слизової ротової порожнини) - почати обробку ротової порожнини оральними антисептиками (орасепт, гивалекс, стоматидин), при погіршенні стану - дифлюкан по 150 мг всередину (за узгодженням).
3. Дотримання питного режиму - вживання не менше 2-2.5л рідини на добу (під контролем діурезу та показників артеріального тиску!)
4. При сухості шкіри - використання жирних кремів та косметичних масел, при сухості кон'юнктиви - краплі «Штучні сльози» або «Хіло-Кеа». При сухості слизової носа - спрей «Аква-Марис» або «Х'юмер», «Марімер», масляні розчини хлорофіліпту, масло обліпихи, оливкова олія. Обробляти слизову оболонку носа синтоміциновою маззю 2-3 рази на день 10 днів.
5. Загальний аналіз крові, контроль біохімічних показників, огляд онколога 20.02.2023р.
6. При підвищенні температури тіла вище 38.0С, розпочати антибактеріальну терапію (за погодженням з лікарем!!!).
7. При запорак - Дуфалак по 20 мл 1 раз на день щодня після сніданку.
8. При проносі почати Імодіум-2 капс. одразу, потім по 1 капс. після кожного епізоду рідкого випорожнення (до 8 капс на добу).
9. При погіршенні самопочуття-тел. чергового лікаря 096 8151618
10. Сорбіфер по 1 таб 2 рази на день за 30 хв. до їжі щоденно.
11. Еліквіс по 2.5 мг 2 рази на день тривало.
12. Віт д3 по 4 тис Од/день 3 міс суммарно.
13. Виконувати рекомендації травматолога.
14. Виконувати рекомендації ендокринолога.
15. Бептрал по 500 мг 2 рази на день. 16.02.2023
16. КальційД3 по 1 таб 2 рази на день під час прийому їжі.

Клінічний діагноз

Основний: Діагноз: Лейоміосаркома матки T2NxM1 (печінка, брюшина).

Стан після 4-х циклів хіміотерапії по протоколу Гемцитабін+Доцетаксел+Авастин з прогресією в печінці (КТ 01.12.2022).

Виявлено мутації Kit, MET (повногеномне секвенування ONCOMINE, 12.2022).

Лікування Пазопанібом 05-12.01.2023р. з розвитком синдрому задньої зворотньої енцефалопатії та позитивної динаміки по даним КТ 09.02.2023р. Заключення: КТ-ознаки вторинного ураження паренхіми печінки, міжпелетельний імплант лівого мезогастрія, об'ємне утворення в проекції правого яєчника (імплант в Дугласовому просторі?), мінімальні ознаки біліарної гіпертензії. Від 04.01.2023р динаміка позитивна - регрес вогнищ в печінці на 12%, зменшення в розмірах міжпелетельного імпланту на 15%.

Супутній діагноз: Залізодефіцитна анемія. Цукровий діабет 2 тип. Гіповітаміноз Д.

Закритий відламковий перелом дистального метаепіфізу лівої променевої кістки зі зміщенням відламків (11.02.2023р.)

Лікар

/Лациннікова О.М./